MINISTERIO DE SALUD

No. 1176-2023/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 29 de Diciembre del 2023

Visto, el Expediente N° DGIESP20230001873, que contiene el Memorándum N° D006019-2023-DGIESP-MINSA y el Informe N° D000319-2023-DGIESP-DPCEM-MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D001337-2023-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas, y su artículo 4 dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otras;

Que, con Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA se aprueba la NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú, que establece los criterios técnicos y administrativos para la vigilancia, prevención y control de la rabia en el Perú;

MINISTERIO DE SALUD Ministro C. VÁSQUEZ

MINISTERIO DE SALUD Viceministerio de Salud Pública E. PEÑA

MINISTERIO DE SALUD O.G. ASESORÍA JURÍDICA C. DIAZ V.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General M. MENDOCILLA

MINISTERIO DE SALUD O.G. ASESORÍA JURÍDICA C. MARTINEZ V.

Que, el numeral 6.2.1 de la mencionada Norma Técnica de Salud regula lo referido a las vacunas antirrábicas para uso en humanos, y su numeral 6.2.4 establece el esquema de vacunación post exposición, con vacuna antirrábica;

Que, de otro lado, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, señala que la Dirección General de intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar intervenciones estratégicas de salud pública en diversas materias;

Que, con los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública manifiesta que la normativa vigente sobre vigilancia, prevención y control de la rabia humana en el Perú establece la vía intramuscular como única forma de aplicación de la vacuna humana. Sin embargo, existe la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a que también se puede aplicar la vía intradérmica de las vacunas antirrábicas cultivo celular, como una alternativa segura, inmunogénica, económica y de bajo costo a la administración intramuscular;

Que, en tal sentido, la citada Dirección General propone la modificación de la NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA, para adicionar el esquema vacunal y aplicación de la vacuna antirrábica humana vía intradérmica en el país, según prescripción médica;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y del Despacho Viceministerial de Salud Pública;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los numerales 6.2.1 y 6.2.4 de la NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, y que se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

ANEXO

MODIFICACIÓN DE LA NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA

Se modifican los numerales 6.2.1 y 6.2.4 de la NTS N° 131-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial N° 024-2017/MINSA, de acuerdo al siguiente texto:

"VI DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

6.2. VACUNA ANTIRRABICA PARA HUMANOS

6.2.1 Vacunas para uso en humanos

En el Perú se usa la Vacuna antirrábica de cultivo celular (VCC) (Anexo N°03).

Vacunas antirrábicas de cultivo celular (VCC)

Las vacunas pueden administrarse por vía intradérmica o intramuscular.

La inmediata administración de VCC, con la administración simultánea de inmunoglobulina antirrábica cuando está indicada y una adecuada atención de la herida por mordedura, aún después de exposiciones de alto riesgo.

Como con cualquier producto farmacéutico, cuando se utilizan biológicos antirrábicos se deben tener en cuenta consideraciones mínimas que incluyen el entrenamiento adecuado, almacenamiento, manejo, administración, precauciones de control de infecciones y una técnica estéril.

a) ***Características y Conservación**: Las vacunas antirrábicas basadas en cultivo celular y en huevos embrionados (VCC), concentradas y purificadas, deben conservarse a una temperatura de 2° a 8° C, protegidas de la luz solar y, una vez reconstituidas, deben ser* conservadas de acuerdo a las indicaciones establecidas en el inserto.

b) ***Potencia de la Vacuna:** La potencia mínima aceptable de las vacunas de cultivo celular es de 2,5 unidades internacionales (UI) por dosis intramuscular, según lo determinado en la prueba de potencia NIH (National Institute of Health).*

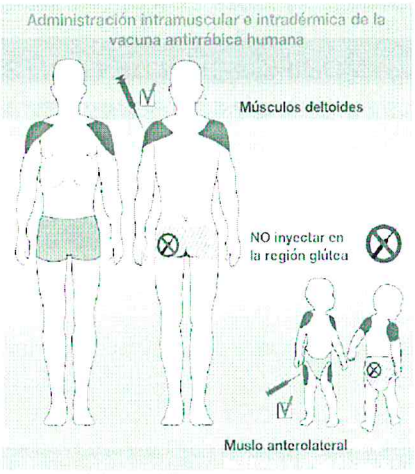
El nivel de anticuerpos protectores en suero es de 0,5 UI/ml.

c) ***Dosis y vía de aplicación***
Las vacunas antirrábicas se producen en dosis individuales.

La vacuna antirrábica no debe ser administrada en la zona glútea, dado que la inducción de una respuesta inmune adecuada es menos fiable. No debe inyectarse por la vía subcutánea, ni intravascular. La dosis no depende de la edad ni del peso del paciente.

- *Vía intramuscular*

Una dosis intramuscular es un vial entero de vacuna, independientemente del tamaño del vial.



La vacuna debe inyectarse en el músculo deltoides para adultos y niños ≥ 2 años de edad; y para niños < 2 años, se recomienda el muslo anterolateral.

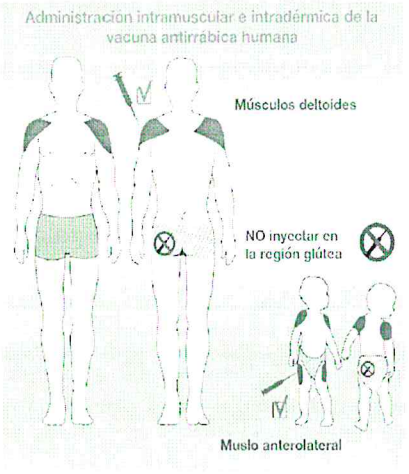
Para la reconstitución de la vacuna se debe utilizar la jeringa de 3ml con aguja de 21G x 1 ½".

Para la aplicación o inyección de la vacuna, se debe utilizar la jeringa de 1 ml con aguja de 25 G x 1 ½" retráctil.

En caso de una nueva exposición teniéndose antecedente vacunal contra la rabia con esquema completo de profilaxis pre exposición o post, no se indica suero antirrábico o inmunoglobulina antirrábica (RIG) y se aplica administración intramuscular en un solo sitio de un vial completo de la vacuna en los días 0 y 3.

- *Vía intradérmica*

Una dosis vía intradérmica corresponde a 0,1 mL de vacuna. Las inyecciones intradérmicas (ID) se administran en la dermis justo debajo de la epidermis.



Para la administración intradérmica, los sitios recomendados incluyen: La región de los deltoides (tercio medio de la región deltoides del brazo), la región de los muslos laterales o las zonas supraescapulares que drenan en los ganglios linfáticos regionales. En adultos y niños mayores de 2 años, en el tercio medio de la región deltoides de los brazos; y en menores de 2 años en el Tercio medio de la región deltoides de los brazos y en los muslos. En caso se tengan lesiones de mordedura en dichas regiones, se deben contemplar otros sitios anatómicos comunes utilizados para las inyecciones intradérmicas, como la superficie interna del antebrazo y la parte superior de la espalda debajo de la escápula.

Se debe verificar que la piel y los tejidos se encuentren sanos, y no aplicar encima de tatuajes, lunares, erupciones, cicatrices que impidan la visibilidad o formación de la pápula.

Se debe desinfectar el lugar de la inyección con antiséptico, luego estirar la superficie de la piel e insertar la punta de la aguja (borde biselado hacia arriba) en la capa superior de la piel (dermis), en un ángulo de 5° a 15° hasta que el bisel desaparezca asegurándose de que la aguja y la jeringa estén casi paralelas a la superficie de la piel. Luego, comenzar a inyectar la vacuna. Si la aguja está en la posición correcta, hay una resistencia considerable. Una pápula elevada, que parece piel de naranja, aparecerá de inmediato y medirá de 6-8 mm de diámetro, desapareciendo entre 10 a 30 minutos. Debe explicarse a los usuarios, padres o cuidadores que en el sitio de aplicación de la vacuna no se deben realizar masajes, ni colocar compresas o administrar medicamentos.

Se recomienda alternar la extremidad de aplicación de la vacuna, en los casos donde

C. DIAZ V.

no se puedan o se deban aplicar otros biológicos; se deben tener como mínimo 2,5 centímetros de distancia entre los lugares de inyección.

El personal de salud debe tener cuidado de no inyectar menos de la dosis recomendada por esta vía.

Para la reconstitución de la vacuna, se debe utilizar la jeringa de 3ml con aguja de 21G x 1 1/2."

Para la aplicación o inyección de la vacuna, se debe utilizar la jeringa de 1ml con aguja 27G X ½" retráctil.

En caso de una nueva exposición teniéndose antecedente vacunal contra la rabia con esquema completo de profilaxis pre exposición o post exposición, no se indica suero antirrábico o inmunoglobulina antirrábica (RIG) y se administra la vacuna intradérmica en un solo sitio en los días 0 y 3.

La aplicación vía intradérmica es una alternativa segura, inmunogénica, económica y de bajo costo a la administración intramuscular, especialmente en situaciones de suministro y recursos financieros limitados, reduciendo así el volumen utilizado en comparación con la inyección intramuscular estándar.

d) ***Cadena de Frío:*** *Los establecimientos de salud en todos los niveles deben garantizar la cadena de frío para la conservación de los biológicos antirrábicos humanos, según normatividad vigente.*

(...)

6.2.4. Esquema de vacunación post exposición de Vacunas para uso en humanos

Esquemas de Vacunación antirrábica con VCC

- *Post exposición*

Esquema Post exposición	*Duración de esquema*	*N° de sitios de inyección por consulta clínica – días 0, 3, 7, 14, 28*
Intradérmico	*1 mes, dos sitios*	*2-2-2-0-2*
Intramuscular	*1 mes, 1 sitio*	*1-1-1-1-1*

- *En caso de nueva exposición con antecedente vacunal completo, se aplican refuerzos de acuerdo al siguiente esquema:*

Esquema Post exposición	*Duración de esquema*	*N° de sitios de inyección por consulta clínica – días 0, 3, 7, 14, 28*
Intradérmico	*1 semana, 1 sitio*	*1-1-0-0-0*
Intramuscular	*1 semana, 1 sitio*	*1-1-0-0-0*

El día 0 es la fecha de administración de la primera dosis de la vacuna. que puede coincidir con el día en que esta persona sufrió el contacto o fue agredida."